

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Faculté de Médecine CONSTANTINE 3
Département de Médecine

2^{ème} ANNEE DE MEDECINE

LES TROMPES UTERINES

Dr A.M CHABIL

Service d'Histologie Embryologie et Génétique Clinique

CHUC

2023/2024

TROMPES UTERINES

1 .Introduction :

- Les trompes utérines sont impliquées dans le transport des gamètes et des embryons.
- Après l'ovulation, le complexe cumulo-ovocytaire est capté par la trompe utérine (infundibulum).
- C'est à son niveau qu'à lieu généralement la fécondation.
- Les trompes utérines sont des conduits musculo-membraneux mesurant 12 cm de longueur.
- Quatre régions peuvent être distinguées au niveau des trompes utérines, de l'extrémité vers l'utérus :
 - Le pavillon de la trompe,
 - L'ampoule tubaire,
 - L'isthme tubaire
 - Et le segment intra-mural situé dans l'épaisseur de la paroi utérine.

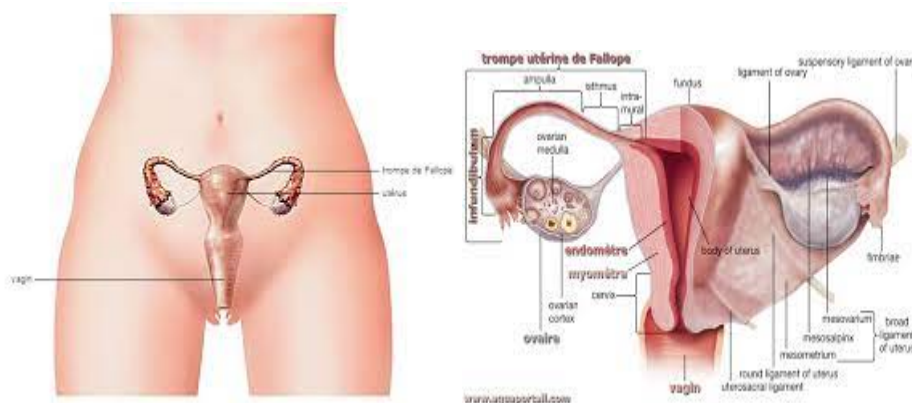


FIG 1 :Trompes utérines

2. Structure histologique :

- Les trompes utérines comportent trois tuniques cellulaires, la muqueuse, la musculieuse et la séreuse.

2.1. La muqueuse :

- La muqueuse de la trompe est formée d'un épithélium prismatique simple avec des cellules à cils vibratiles et des cellules sécrétrices, et d'un chorion contenant des cellules musculaires lisses, des capillaires sanguins et des terminaisons nerveuses.

- L'extrémité libre de la trompe, le pavillon, possède une frange faite de prolongements digitiformes.

- La paroi de l'ampoule tubaire comprend une muqueuse qui forme de nombreux replis.

- Au niveau de l'isthme tubaire, la lumière de la trompe utérine se rétrécit progressivement et les plis de la muqueuse se raréfient.

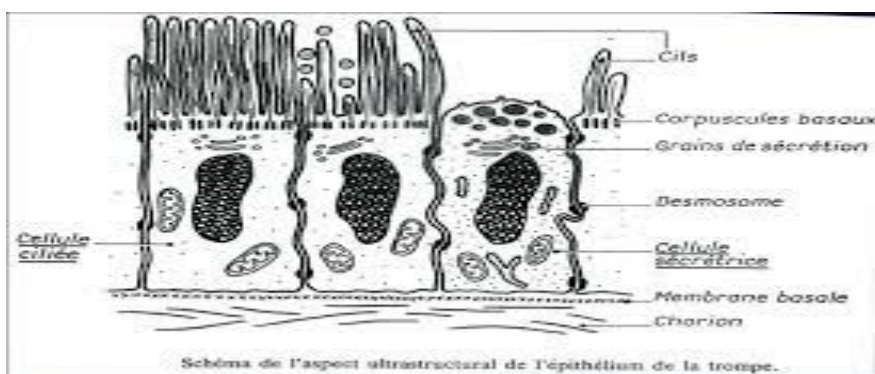


FIG2 :Ultrastructure de l'épithélium tubaire

2.2. La musculieuse :

- Très mince au niveau du pavillon (et même absente dans la plupart des franges), elle augmente d'épaisseur au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'utérus.

- La tunique musculaire est formée de muscle lisse organisé en deux couches :

- ✓ Circulaire interne
- ✓ Et longitudinale externe.

2.3. La séreuse :

- C'est une couche conjonctivo-élastique très vascularisée.

- Elle est recouverte par le mésothélium péritonéal et se continue par le conjonctif du mésosalpinx.

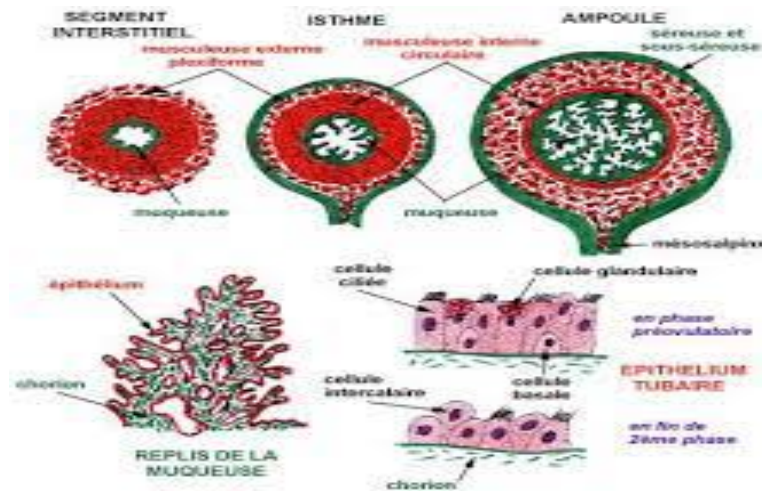


FIG 3 : Coupes faites à différents niveaux de la trompe utérine

3. Histo-physiologie :

- Les trompes ont des fonctions complexes.
- La trompe est le lieu de la fécondation (1/3 externe) et la segmentation.
- Après cela elles assurent la survie et la migration du zygote vers la cavité utérine où se fera l'implantation.
- En cas de fécondation ; le transport de l'œuf jusqu'à l'utérus s'effectue pendant trois jours.
- La capture de l'ovule expulsé lors de la rupture folliculaire.
- Le pavillon mobile ; vient coiffer l'ovaire vers le milieu du cycle.
- En quelques heures, l'ovule (ovocyte II entouré de la pellucide et de la Corona radiata) gagne l'ampoule tubaire sous l'action des contractions péristaltiques de la trompe.
- Cette activité péristaltique est augmentée par les oestrogènes et est diminuée par la progestérone.
- La migration et la survie des spermatozoïdes : La progression des spermatozoïdes vers le

tiers externe de la trompe est facilitée par le flux liquidien, les contractions utérines et les contractions tubaires.

- Le liquide tubaire augmente la mobilité des spermatozoïdes.
- Le liquide provient de la sécrétion des cellules épithéliales tubaires.

4. Pathologie :

4.1. La salpingite :

- La salpingite est une inflammation d'une trompe de Fallope chez la femme, causée par une infection sexuellement transmissible (IST) ; généralement une Infection par d'une bactérie Chlamydia Trachomatis , qui passe inaperçue dans 50 à 70% des cas.
- C'est pour cela qu'elle est fréquemment diagnostiquée lors d'un bilan pour stérilité, dont elle peut être la cause.
- Cette inflammation peut laisser des séquelles à long terme, telles qu'une infertilité (Empêche la progression des spermatozoïdes et la fécondation), un risque accru de grossesse extra utérine et des douleurs pelviennes chroniques.
- Elle peut engendrer un abcès pelvien ou une péritonite.

4.2. La grossesse extra utérine :

- Une grossesse extra-utérine(GEU), aussi appelée grossesse ectopique, survient lorsque l'ovule fertilisé s'implante à l'extérieur de l'utérus.

L'ovule se loge :

- Le plus souvent dans une des trompes de Fallope : on parle alors de grossesse tubaire ; plus rarement dans l'ovaire : on parle de grossesse ovarienne ; dans la cavité péritonéale : on parle de grossesse abdominale.
- Souvent, c'est une anomalie de la trompe qui a gêné la migration de l'œuf : anomalie congénitale ou acquise (séquelles de salpingite, intervention chirurgicale sur la trompe etc...).

- Une grossesse extra-utérine ne peut être menée à terme normalement et nécessite une intervention d'urgence .
- Si l'œuf fécondé n'est pas retiré, son évolution peut entraîner l'éclatement de la trompe de Fallope, ce qui peut provoquer une grave hémorragie pouvant être mortelle pour la femme.